

- 57★★★
☑☑☑ BO は肺移植以外には有効性の確立された治療法がない。
- 58★★★
☑☑☑ BO の 5 年生存率は 50% 以上である。
- 59★★★
☑☑☑ 造血幹細胞移植後に BO を生じることがある。
- 60★★★
☑☑☑ 末梢血幹細胞移植よりも骨髓移植で BO が生じやすい。
- 61★★★
☑☑☑ 造血幹細胞移植後の BO は慢性 graft-versus-host disease (GVHD) の表現型の 1 つとされる。
- 62★★★
☑☑☑ 造血幹細胞移植後の肺合併症の中では、BO の頻度が最多である。
- 63★★★
☑☑☑ 造血幹細胞移植後の BO の発生率は 1% 未満である。
- 64★★★
☑☑☑ 急性 GVHD を合併しなかった患者の方が BO の頻度が多い。
- 65★★★
☑☑☑ プスルファンは BO の発症リスクを高める。
- 66★★★
☑☑☑ 造血幹細胞移植後の BO の診断までの中央値は 2 年以上である。
- 67★★★
☑☑☑ 他臓器に慢性 GVHD を発症した症例では、BO の発症率も増加する。
- 68★★★
☑☑☑ 造血幹細胞移植後には息切れなどを生じた場合にはじめて肺機能検査を検討する。
- 69★★★
☑☑☑ 造血幹細胞移植後に生じた BO に対し肺移植を行った場合、移植肺に BO が発生することはない。
- 70★★★
☑☑☑ 原疾患を問わず、肺移植を行った場合には、移植後 5 年までに BO を発症する率は 10% 程度である。
- 71★★★
☑☑☑ 臓器移植後に生じる、閉塞性細気管支炎症候群 (bronchiolitis obliterans syndrome: BOS) の概念は病理学的診断を必須としないことが特徴である。

